Dr.Reddy's

TERONRED

Abiraterona 250mg

TABLETAS RECUBIERTAS

Documentos para Evaluación Técnico-Científico

Texto de Información para Prescribir

-PROPIEDAD EXCLUSIVA DE DR. REDDY´S LABORATORIES LIMITED-

Agradecemos que estos documentos sean manejados de manera confidencial sin divulgar su información y exclusivamente para el fin requerido de realizar la evaluación técnico-científica.

TERONRED
Acetato de abiraterona - Tabletas de 250 mg

COMPOSICION
Cada tableta recubierta contiene:
250 mg de acetato de abiraterona
Color: Dióxido de Titanio

INFORMACION CLINICA

Indicaciones

Abiraterona en combinación con prednisona o prednisolona, está indicada para:

- El tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (mCRPC, por sus siglas en inglés) que sean asintomáticos o levemente sintomáticos, tras el fracaso con el tratamiento de deprivación de andrógenos.
- El tratamiento del cáncer de próstata metastásico avanzado (cáncer de próstata resistente a la castración) en pacientes que han recibido quimioterapia previa conteniendo un taxano

Abiraterona está indicada en combinación con prednisona o prednisolona y con terapia de deprivación de andrógenos (ADT, por sus siglas en inglés) para el tratamiento de cáncer de próstata metastásico de alto riesgo sin tratamiento hormonal previo (mHNCP, por sus siglas en inglés) o para el tratamiento de cáncer de próstata metastásico sensible a hormonas (mHSPC, por sus siglas en inglés) de diagnosticado reciente de alto riesgo.

Posología y método de administración
Este medicamento debe ser prescrito por un profesional de la salud facultado para ello.

Posología
La dosis recomendada es de 1000 mg (cuatro tabletas de 250 mg) en una sola dosis diaria que no se debe tomar con alimentos. La toma de las tabletas con alimentos aumenta la exposición sistémica a abiraterona.

Posología de prednisona o prednisolona

En el mHSPC, abiraterona se utiliza con 5 mg de prednisona o prednisolona al día.
En el mCRPC, abiraterona se utiliza con 10 mg de prednisona o prednisolona al día.

Se debe mantener la castración médica con un análogo de la hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH) durante el tratamiento en los pacientes no sometidos a castración quirúrgica.

Monitorización recomendada

Se debe medir las concentraciones séricas de transaminasas antes de iniciar el tratamiento, cada dos semanas durante los tres primeros meses de tratamiento y posteriormente una vez al mes. Una vez al mes se debe monitorizar la presión arterial, el potasio sérico y la retención de líquidos. Sin embargo, se debe monitorear a los pacientes con un riesgo significativo de insuficiencia cardiaca congestiva cada 2 semanas durante los primeros tres meses de tratamiento y posteriormente una vez al mes.

En los pacientes con hipopotasemia preexistente o en aquellos que desarrollan hipopotasemia durante el tratamiento con abiraterona, se debe considerar mantener el nivel de potasio del paciente ≥ 4,0 mM.

Para los pacientes que desarrollan toxicidades de Grado ≥ 3, incluyendo hipertensión, hipopotasemia, edema y otras toxicidades no relacionadas con los mineralocorticoides, se debe suspender el tratamiento y establecer un control médico apropiado. El tratamiento con abiraterona no se debe reanudar hasta que los síntomas de la toxicidad se hayan resuelto a Grado 1 o a los valores iniciales.

Si se olvida una dosis diaria de abiraterona, prednisona o prednisolona, se debe reanudar el tratamiento al día siguiente con las dosis diarias habituales.

Hepatotoxicidad
El tratamiento deberá suspenderse inmediatamente en los pacientes que durante el tratamiento desarrollan hepatotoxicidad (elevación de la alanina aminotransferasa [ALT, por sus siglas en inglés] o aspartato aminotransferasa [AST, por sus siglas en inglés] más de cinco (5) veces por encima del límite superior normal [ULN por sus siglas en inglés]). Después que las pruebas de la función hepática hayan confirmado que los valores regresaron a los niveles basales, se puede reiniciar el tratamiento a dosis reducidas de 500 mg (dos tabletas) una vez al día. Las transaminasas séricas deberán controlarse cada dos semanas por los primeros tres meses de tratamiento; y luego, mensualmente en los pacientes que reinician el tratamiento. Si reaparece la hepatotoxicidad a una dosis reducida de 500 mg diarios, el tratamiento deberá suspenderse.

Si los pacientes desarrollan hepatotoxicidad (veinte (20) veces por encima del ULN de la ALT o la AST) en cualquier momento durante el tratamiento, se debe suspender el tratamiento y estos pacientes no deberán reiniciar este tratamiento.

Insuficiencia hepática
No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia hepática leve preexistente, Clase A de Child-Pugh..

Después de una dosis única oral de 1000 mg de acetato de abiraterona, se ha demostrado que la insuficiencia hepática moderada (Child-Pugh Clase B) incrementa la exposición sistémica

a abiraterona en aproximadamente cuatro veces. No se cuenta con información sobre la seguridad clínica y la eficacia después de múltiples dosis de acetato de abiraterona cuando se administra a pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave (Child-Pugh Clase B o C). No se ha podido predecir el ajuste de la dosis. El uso de abiraterona debe ser cuidadosamente evaluado en pacientes con insuficiencia hepática moderada en los cuales el beneficio debe superar claramente el posible riesgo. Abiraterona no deberá utilizarse en pacientes con insuficiencia hepática grave.

Insuficiencia renal
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal. Sin embargo, no se cuenta con experiencia clínica en pacientes con cáncer de próstata e insuficiencia renal grave; por lo que se recomienda tener precaución con estos pacientes.

Población pediátrica
Abiraterona no se ha utilizado de manera relevante en la población pediátrica.

Método de Administración

Abiraterona es para uso oral

Abiraterona deberá administrarse por lo menos dos horas después de haber comido y el paciente no deberá tomar ningún alimento por lo menos una hora después de haber ingerido las tabletas. Las tabletas deberán tragarse enteras con agua.

Contraindicaciones
- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de sus excipientes.
- Embarazo

Advertencias Especiales y Precauciones Especiales para su Uso

Hipertensión, hipocalemia y retención de líquidos a causa de un exceso de mineralocorticoides.

Abiraterona puede causar hipertensión, hipocalemia y retención de líquidos como consecuencia de niveles aumentados de mineralocorticoide que resulta de la inhibición del CYP17. La coadministración de un corticoesteroide suprime el efecto de la hormona adrenocorticotrópica (ACTH por sus siglas en inglés), que tiene como resultado una reducción de la incidencia y la gravedad de estas reacciones adversas. Se recomienda tener precaución con los pacientes bajo tratamiento que debido a sus condiciones médicas subyacentes pueden verse comprometidos por el aumento en la presión arterial, hipocalemia (p. ej. aquellos pacientes con glucósidos cardíacos), retención de líquido (p. ej. aquellos con insuficiencia cardíaca), angina de pecho grave o inestable, infarto reciente al miocardio, arritmia ventricular y aquellos pacientes con insuficiencia renal grave.

Abiraterona deberá utilizarse con precaución en pacientes con un antecedente de enfermedad cardiovascular. Los estudios Fase III realizados con abiraterona excluyeron los pacientes con hipertensión no controlada, con enfermedad cardíaca clínicamente significativa evidenciada por infarto del miocardio o episodios trombóticos arteriales presentados en los últimos 6 meses, angina grave o inestable, insuficiencia cardíaca Clase III o IV de la New York Heart Association (NYHA) (Estudio 301) o insuficiencia cardíaca Clases II a IV (Estudios 3011 y 302) o fracción de eyección cardíaca < 50%. En los estudios 3011 y 302 se excluyeron los pacientes con fibrilación auricular u otra arritmia cardíaca con necesidad de tratamiento médico. No pudo establecerse la seguridad en los pacientes con fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) < 50% o con insuficiencia Clase III o IV de la NYHA (en el estudio 301) o con insuficiencia cardíaca Clase II a IV de la NYHA (en los estudios 3011 y 302).

Antes de tratar a los pacientes con un riesgo significativo de insuficiencia cardíaca congestiva (p. ej. antecedentes de insuficiencia cardíaca, hipertensión no controlada o eventos cardíacos como enfermedad cardíaca isquémica), debe considerarse obtener una evaluación de la función cardíaca (p. ej. ecocardiograma). Antes de iniciar tratamiento con abiraterona, deberá tratarse la insuficiencia cardíaca y optimizarse la función cardíaca. Deberán corregirse y controlarse la hipertensión, la hipocalemia y la retención de líquidos. Durante el tratamiento, cada dos semanas por los primeros tres meses de tratamiento; y luego, mensualmente, deberán monitorearse la presión arterial, el potasio en suero, la retención de líquidos (ganancia de peso, edema periférico) y otros signos y síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva y deberán corregirse las anomalías. Se ha observado prolongación del intervalo QT en pacientes que experimentan hipocalemia asociada a la administración de abiraterona. Si se presenta una disminución clínicamente significativa en la función cardíaca, deberá valorarse la función cardíaca como está clínicamente indicado, iniciar un manejo adecuado y considerar la suspensión de este tratamiento.

Hepatotoxicidad e insuficiencia hepática

Marcados aumentos de las enzimas hepáticas exigieron la suspensión del tratamiento o la modificación de la dosis en estudios clínicos controlados. Antes de iniciar el tratamiento, debieron medirse los niveles de transaminasa sérica cada dos semanas por los primeros tres meses de tratamiento; y luego, mensualmente. Si algunos síntomas o signos clínicos sugerían desarrollo de hepatotoxicidad, las transaminasas séricas deberían medirse de inmediato. Si en cualquier momento la ALT o AST aumentan más de 5 veces el ULN, el tratamiento deberá interrumpirse inmediatamente y la función hepática deberá controlarse estrechamente. El tratamiento sólo deberá reiniciarse cuando las pruebas demuestren que los niveles de la función hepática retornaron al valor basal y se podrá reiniciar a un nivel de dosis reducido.

Si en cualquier momento durante el período de tratamiento los pacientes desarrollan hepatotoxicidad grave (ALT o AST 20 veces por encima del ULN), el tratamiento deberá suspenderse y no se debe reanudar en estos pacientes.

Los pacientes con hepatitis vírica sintomática o activa fueron excluidos de los estudios clínicos; en consecuencia no se cuenta con datos que soporte el uso de abiraterona en esta población.

No existe información sobre la seguridad y eficacia clínica de dosis múltiples de acetato de abiraterona cuando se administra a pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave(Child-Pugh Clase B o C). El uso de abiraterona deberá ser cautelosamente evaluado en pacientes con insuficiencia hepática moderada, en los cuales el beneficio debe superar claramente el posible riesgo. Abiraterona no deberá utilizarse en pacientes con insuficiencia hepática grave.

Durante la comercialización, se han reportado casos raros de insuficiencia hepática aguda y hepatitis fulminante, algunos con resultados fatales.

Retiro del corticoesteroide y respuestas a situaciones de estrés

Se recomienda precaución y control de insuficiencia adrenocortical si los pacientes dejan de tomar prednisona o prednisolona. Si se sigue administrando abiraterona después de haber descontinuado los corticoesteroides, los pacientes deberán monitorearse respecto a síntomas por exceso de mineralocorticoides.

En aquellos pacientes tratados con prednisona o prednisolona que están sujetos a estrés inusual, puede estar indicado un aumento de la dosis de corticoesteroides antes, durante y después de la situación estresante.

Densidad ósea
En hombres con cáncer de próstata metastásico avanzado puede presentarse reducción de la densidad ósea. El uso de abiraterona en combinación con un glucocorticoide, puede aumentar este efecto.

Uso previo de ketoconazol
En pacientes que previamente han sido tratados con ketoconazol para el cáncer de próstata, se pueden esperar menores tasas de respuesta.

Hiperglicemia
El uso de glucocorticoides puede incrementar la hiperglicemia; por lo tanto, en pacientes con diabetes, el azúcar en sangre deberá medirse frecuentemente.

Uso con quimioterapia
No se ha establecido la seguridad y eficacia del uso concomitante de abiraterona con quimioterapia citotóxica.

Intolerancia a los excipientes
Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa,

insuficiencia de lactasa de Lapp o malabsorción de glucosa-galactosa no deben tomar este medicamento. Este medicamento también contiene más de 1 mmol (o 27,2 mg) de sodio por dosis de cuatro comprimidos, lo que deberá tenerse en cuenta en el tratamiento de pacientes con dietas pobres en sodio.

Riesgos potenciales
En hombres con cáncer de próstata metastásico, incluyendo aquellos pacientes que están bajo tratamiento con abiraterona, puede presentarse anemia y disfunción sexual.

Efectos musculoesqueléticos
En pacientes tratados con abiraterona, se han reportado casos de miopatía. Algunos pacientes presentan rabdomiólisis con insuficiencia renal. La mayoría de los casos se desarrollan dentro del primer mes de tratamiento y se recuperan después de la suspensión de abiraterona. Se recomienda precaución en los pacientes tratados concomitantemente con medicamentos que se sabe que están asociados con miopatía/rabdomiólisis.

Interacciones con otros medicamentos
A menos que no haya una alternativa terapéutica, durante el tratamiento deberán evitarse los inductores potentes del CYP3A4, debido al riesgo de disminución de la exposición a abiraterona.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

Efecto de los alimentos sobre el acetato de abiraterona
La administración con alimentos, aumenta significativamente la absorción del acetato de abiraterona. No se ha establecido aún la eficacia y seguridad de abiraterona cuando se administra con alimentos; por lo tanto, este medicamento no deberá administrarse con los alimentos.

Interacciones con otros medicamentos
Posibilidad de que otros medicamentos afecten las exposiciones a abiraterona

En un estudio de interacción farmacocinética clínica con la participación de sujetos sanos previamente tratados con rifampicina, inductor potente del CYP3A4, 600 mg al día por un período de 6 días, seguidos de una dosis única de 1000 mg de acetato de abiraterona, el ABCα media plasmática de abiraterona se redujo un 55%.

A menos que no haya una alternativa terapéutica, durante el tratamiento deberán evitarse los inductores potentes del CYP3A4 (Ej. fenitoína, carbamazepina, rifampicina, rifabutina, rifaopeontina, fenobarbital, hierba de San Juan [*Hypericum perforatum*]).

En otro estudio de interacción farmacocinética clínica con la participación de sujetos sanos, la coadministración de ketoconazol, un fuerte inhibidor del CYP3A4, no tuvo efecto

clínicamente significativo sobre la farmacocinética de abiraterona.

Posibilidad de que afecte a la exposición de otros medicamentos

Abiraterona es un inhibidor de las enzimas hepáticas metabolizadoras de medicamentos CYP2D6 y CYP2C8.

En un estudio realizado para determinar los efectos del acetato de abiraterona (más prednisona) en una dosis única de dextrometorfano, un substrato de CYP2D6, la exposición sistémica (ABC) de dextrometorfano se incrementó en aproximadamente 2.9 veces. El ABC_{24} para el dextrorfan, metabolito activo del dextrometorfano, aumentó aproximadamente un 33%.

Se recomienda precaución cuando se administra con medicamentos activados por o metabolizados por el CYP2D6, particularmente con medicamentos que tienen un índice terapéutico estrecho; por lo tanto, deberá considerarse la reducción de la dosis de los medicamentos con índice terapéutico estrecho que son metabolizados por el CYP2D6. Algunos ejemplos de medicamentos metabolizados por el CY2D6, incluyen: metoprolol, propanolol, desipramina, venlafaxina, haloperidol, risperidona, propafenona, flecainida, codeína, oxicodona y tramadol (los últimos tres medicamentos requieren del CYP2D6 para formar sus metabolitos analgésicos activos).

En un estudio de interacción fármaco-fármaco CYP2C8 ene sujetos sanos, el ABC de la pioglitazona aumentó en un 46% y las ABC para M-III y M-IV, los metabolitos activos de la pioglitazona disminuyeron en un 10% cada uno cuando se administró la pioglitazona junto con una dosis única de 1000 mg de acetato de abiraterona. Aunque estos resultados indicaban que en la exposición no era de esperarse aumentos clínicamente significativos cuando abiraterona se combinaba con medicamentos que fueron predominantemente eliminados por el CYP2C8, los pacientes debían ser monitoreados para descartar signos de toxicidad relacionados con un sustrato del CYP2C8 con un índice terapéutico estrecho si se utilizaba concomitantemente.

In vitro, los metabolitos principales sulfato de abiraterona y el sulfato de N-óxido abiraterona demostraron inhibir la absorción hepática del transportador OATP1B1. No se cuenta con información clínica disponible para confirmar la interacción con base en el transportador.

Uso con productos que se sabe prolongan el intervalo QT
Debido a que el tratamiento de deprivación de andrógenos puede prolongar el intervalo QT, se recomienda tener precaución cuando se administra abiraterona con medicamentos que se sabe que prolongan el intervalo QT o con medicamentos que están en capacidad de inducir el Torsade de pointes (puntas retorcidas) como los de la Clase IA (p. ej. quinidina, disopiramida) o de la Clase III (p. ej. amiodarona, sotalol, dofetilida, ibutilida), los medicamentos antiarrítmicos, metadona, moxifloxacina, antipsicóticos, etc.

Uso con Espironolactona

Espironolactona se une al receptor androgénico y puede producir aumento de los niveles de antígeno específico prostático (PSA). No se recomienda el uso concomitante con abiraterona.

Fertilidad, Embarazo y Lactancia

Mujeres en Edad de Procrear

No se dispone de información en seres humanos sobre el uso de abiraterona durante el embarazo y este medicamento no debe utilizarse en mujeres en edad de procrear.

Anticoncepción en Hombres y Mujeres

Se desconoce si abiraterona o sus metabolitos están presentes en el semen. Se requiere el uso de condón si el paciente tiene una vida sexual activa con una mujer embarazada. Si el paciente lleva una vida sexual activa con una mujer en edad de procrear, deberá utilizar condón al igual que otro método anticonceptivo efectivo. Estudios realizados en animales han demostrado toxicidad reproductiva.

Embarazo

Abiraterona no está indicada para uso en mujeres y está contraindicado en mujeres embarazadas o que potencialmente pueden quedar en embarazo.

Lactancia

Abiraterona no está indicada para uso en mujeres. No se sabe si el Acetato de abiraterona se excreta en leche materna o sus metabolitos se segregan en la leche materna humana.

Fertilidad

Abiraterona afectó la fertilidad en ratas machos y hembras, pero estos efectos fueron totalmente reversibles.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

Abiraterona no tiene ninguna influencia y si la tiene es imperceptible, sobre la habilidad de conducir y utilizar máquinas.

Reacciones Adversas

Resumen del Perfil de Seguridad

En un análisis de las reacciones adversas en el conjunto de estudios Fase III con abiraterona, las reacciones adversas que se observaron en $\geq 10\%$ de los pacientes fueron edema periférico, hipocalemia, hipertensión, infección urinaria, y elevación de la alanina aminotransferasa y/o elevación de la aspartato aminotransferasa.

Otras reacciones adversas importantes, incluyen: trastornos cardíacos, hepatotoxicidad, fracturas y alveolitis alérgica.

Abiraterona puede causar hipertensión, hipocalemia y retención de líquidos como una consecuencia farmacodinámica de su mecanismo de acción. En estudios fase III, se observaron reacciones adversas anticipadas mineralocorticoides más comúnmente en

pacientes tratados con acetato de abiraterona que en pacientes tratados con placebo: hipocalemia 18% versus 8%, hipertensión 22% versus 16% y retención de líquidos (edema periférico) 23% versus 17%, respectivamente. En pacientes tratados con acetato de abiraterona, se observó hipocalemia Grado 3 y 4 de CTCAE (versión 4.0) en el 6% y el 2% de los pacientes, hipertensión arterial Grado 3 y 4 de CTCAE (versión 4.0) en el 8 % y el 5 % de los pacientes, y retención de líquidos (edema periférico) Grados 3 y 4 en el 1% y el 1% de los pacientes, respectivamente. Las reacciones mineralocorticoides generalmente se controlaron bien con tratamiento médico. El uso concomitante de un corticoesteroide reduce la incidencia e intensidad de estas reacciones adversas.

Lista Tabulada de Reacciones Adversas

En estudios de pacientes con cáncer de próstata metastásico avanzado que estaban tomando un análogo de LHRH o que fueron previamente tratados con orquiectomía, abiraterona fue administrada a una dosis de 1000 mg al día en combinación con dosis bajas de prednisona o prednisolona (5 ó 10 mg al día, dependiendo de la indicación).

Las reacciones adversas observadas durante los estudios clínicos y en la experiencia postcomercialización, se relacionan a continuación por categoría de frecuencia. Las categorías de frecuencia se definieron, así: muy común (≥ 1/10); común (≥ 1/100 a < 1/10); poco común (≥ 1/1000 a < 1/100); raros (≥ 1/10000 a < 1/1000); muy raros (< 1/10000) y desconocidos (esta frecuencia no pudo estimarse considerando los datos disponibles).

Dentro de cada grupo de frecuencia, los efectos no deseados se presentan en orden decreciente de gravedad:

Tabla 1: Reacciones Adversas identificadas en Estudios Clínicos y Poscomercialización	
Sistema de Clasificación de Órganos	**Reacciones adversas y Frecuencia**
Infecciones e Infestaciones	Muy común: infecciones del tracto urinario Común: sepsis
Trastornos endocrinos	Poco común: insuficiencia adrenal
Trastornos del metabolismo y nutrición	Muy común: hipocalemia Común: hipertrigliceridemia
Trastornos cardíacos	Común: insuficiencia cardíaca*, angina de pecho, fibrilación auricular, taquicardia Poco común: otras arritmias Desconocidos: infarto al miocardio, prolongación del intervalo QT
Trastornos vasculares	Muy común: hipertensión
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastinales	Raros: alveolitis alérgica[a]
Trastornos gastrointestinales	Muy común: diarrea Común: dispepsia

Trastornos hepatobiliares	Muy común: aumento de alanina aminotransferasa y/o aumento de la aspartato aminotransferasa[b] Raros: hepatitis fulminante, insuficiencia hepática aguda
Trastornos de piel y tejido subcutáneo	Común: erupción
Trastornos musculoesqueléticos y de tejido conjuntivo	Poco común: miopatía, rabdomiólisis
Trastornos renales y urinarios	Común: hematuria
Trastornos generales y condiciones del sitio de administración	Muy común: edema periférico
Lesiones, intoxicaciones y complicaciones de los procedimientos	Común: fracturas**

* La insuficiencia cardíaca también incluye: insuficiencia cardíaca congestiva, disfunción ventricular izquierda y fracción de eyección disminuida.
** Fracturas incluyendo osteoporosis y todas las fracturas con excepción de las fracturas patológicas.
[a] Reportes espontáneos de la experiencia postcomercialización.
[b] Elevación de la alanina aminotransferasa y/o elevación de la aspartato aminotransferasa incluye elevación de la ALT, elevación de la AST y disfunción hepática.

Las siguientes reacciones adversas Grado 3 de CTCAE (versión 4.0) ocurrieron en pacientes tratados con acetato de abiraterona: hipocalemia 5%; infección del tracto urinario 2%, aumento de la alanina aminotransferasa y/o elevación de la aspartato aminotransferasa 4%, hipertensión 6%, fracturas 2%; edema periférico, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular en el 1% cada uno. En < 1 % de los pacientes se observó hipertrigliceridemia Grado 3 de CTCAE (versión 4.0) y angina de pecho. En < 1 % de los pacientes se observó infección urinaria, elevación de la alanina aminotransferasa y/o elevación de la aspartato aminotransferasa, hipocalemia, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y fracturas Grado 4 de CTCAE (versión 4.0).

Se observó una mayor incidencia de hipertensión e hipocalemia en la población hormonosensible (estudio 3011). Se notificó hipertensión en 36,7% de los pacientes en la población hormonosensible (estudio 3011) en comparación con 11,8% y 20,2% en los estudios 301 y 302, respectivamente. Se observó hipocalemia en 20,4% de los pacientes en la población hormonosensible (estudio 3011) en comparación con 19,2% y 14,9% en el 301 y 302, respectivamente.

La incidencia y la gravedad de las reacciones adversas fue mayor en el subgrupo de pacientes con un estado funcional basal ECOG de 2 y también en los pacientes de edad avanzada (≥ 75 años).

Descripción de Reacciones Adversas Seleccionadas

Reacciones cardiovasculares

Los tres estudios Fase III excluyeron a los pacientes con hipertensión, con enfermedad cardíaca clínicamente significativa evidenciada mediante infarto de miocardio o con eventos trombóticos arteriales presentados en los últimos 6 meses, angina grave o inestable o insuficiencia cardíaca Clase III o IV de NYHA (Estudio 301) o insuficiencia cardíaca Clase II a IV (estudios 3011 y 302) o medición de la fracción de eyección cardíaca de < 50%. Todos los pacientes incluidos (tanto pacientes tratados con el medicamento activo o tratados con placebo) fueron tratados concomitantemente con tratamiento de deprivación androgénica, predominantemente con el uso de análogos de la LHRH, los cuales han sido asociados con diabetes, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y muerte cardíaca súbita. La incidencia de las reacciones adversas cardiovasculares en los estudios Fase III en pacientes que recibían acetato de abiraterona versus los pacientes que recibían placebo, fue la siguiente: fibrilación auricular 2.6% versus 2.0%, taquicardia 1.9% versus 1.0%, angina de pecho 1.7% versus 0.8%, insuficiencia cardíaca 0.7% versus 0.2% y arritmia 0.7% versus 0.5%.

Hepatotoxicidad

Se ha reportado hepatotoxicidad con ALT, AST y bilirrubina total elevadas en pacientes tratados con acetato de abiraterona. A lo largo de los 3 estudios clínicos, se notificó hepatotoxicidad de Grados 3 y 4 (p. ej., aumentos de la ALT o AST de > 5 veces el ULN o aumentos de bilirrubina de > 1.5 veces el ULN) fueron reportados de manera típica en aproximadamente el 6% de los pacientes que recibieron acetato de abiraterona, durante los primeros tres meses después de iniciar el tratamiento. En el ensayo 3011, se observó hepatotoxicidad de Grado 3 ó 4 en el 8,4% de los pacientes tratados con abiraterona. Diez pacientes tratados con abiraterona suspendieron el tratamiento por hepatotoxicidad; dos presentaron hepatotoxicidad de Grado 2, seis tuvieron hepatotoxicidad de Grado 3 y dos hepatotoxicidad de Grado 4. Ningún paciente falleció por
hepatotoxicidad en el estudio 3011. En los estudios clínicos fase III, los pacientes con ALT o AST elevadas tenían mayor probabilidad de presentar elevaciones en la prueba de función hepática que aquellos que iniciaron con valores normales. Cuando se observaron elevaciones de la ALT o la AST > 5 veces el ULN o las elevaciones de bilirrubina > 3 veces el ULN el acetato de abiraterona se interrumpió o suspendió. En dos oportunidades se presentaron pruebas de la función hepática marcadamente aumentadas. Estos dos pacientes con función hepática normal al inicio del estudio, experimentaron elevaciones de la ALT o AST de 15 a 40 veces el ULN y elevaciones de bilirrubina de 2 a 6 veces el ULN. Al descontinuar el tratamiento, los dos pacientes normalizaron sus pruebas de la función hepática y uno de los pacientes reinició su tratamiento sin recurrencia de las elevaciones. En el estudio 302, se observaron elevaciones de ALT o AST Grados 3 o 4 en 35 (6.5%) pacientes tratados con acetato de abiraterona. Las elevaciones de aminotransferasas se resolvieron en todos los pacientes, con excepción de tres de ellos (2 con nuevas metástasis hepáticas múltiples y uno con elevación de la AST aproximadamente 3 semanas después de la última dosis de acetato de abiraterona). En los ensayos clínicos Fase III se notificaron suspensiones del tratamiento debido a los incrementos en la ALT y la AST o función hepática anormal en el 1,1% de los pacientes tratados con acetato de abiraterona y en el 0.6% de los pacientes tratados con

placebo; no se reportaron muertes debidas a eventos de hepatotoxicidad.

En los ensayos clínicos, se mitigó el riesgo de hepatotoxicidad porque se excluyeron los pacientes que presentaban hepatitis o anomalías significativas de las pruebas de función hepática. En el ensayo 3011, se excluyeron los pacientes con valores basales de ALT y AST > 2,5 x LSN, bilirrubina > 1,5 x LSN o aquellos con hepatitis vírica activa o sintomática o enfermedad hepática crónica; ascitis o trastornos hemorrágicos secundarios a disfunción hepática. En el ensayo 301, se excluyeron los pacientes con ALT y AST iniciales ≥ 2.5 veces el ULN en ausencia de metástasis hepática y > 5 veces el ULN en presencia de metástasis hepática. En el ensayo 302, los pacientes con metástasis hepática no fueron elegibles y los pacientes con ALT y AST iniciales ≥ 2.5 veces el ULN, fueron excluidos. Las pruebas de función hepática anormal presentadas por pacientes participantes en ensayos clínicos, fueron rigurosamente manejadas exigiendo la interrupción del tratamiento y permitiendo la reiniciación del tratamiento únicamente después de que las pruebas de la función hepática volvieron a los valores basales. Los pacientes con elevaciones de la ALT y la AST > 20 veces el ULN no reiniciaron el tratamiento. Se desconoce la seguridad de un reinicio de tratamiento en tales pacientes. Se desconoce el mecanismo para la hepatotoxicidad.

Sobredosis
La experiencia de sobredosis con abiraterona en humanos es limitada.

No hay antídoto específico. En el evento de una sobredosis, la administración deberá suspenderse y deberán iniciarse medidas generales de soporte, incluyendo monitorias que descarten arritmias, hipocalemia y signos y síntomas de retención de líquidos. La función hepática también deberá evaluarse.

INFORMACION FARMACOLOGICA

Propiedades Farmacodinámicas

Mecanismo de acción

El acetato de abiraterona *in vivo* se convierte en abiraterona, un inhibidor de la biosíntesis androgénica. Específicamente, abiraterona inhibe selectivamente la enzima 17α-hidroxilasa/C17, 20-liasa (CYP17). La expresión de esta enzima es necesaria para la biosíntesis de andrógenos en los tejidos testiculares, suprarrenales y tejidos prostáticos tumorales. EL CYP17 cataliza la conversión de la pregnenolona y la progesterona a precursores de la testosterona, la dehidroepiandrosterona (DHEA) y la androstenediona, respectivamente por 17α-hidroxilación y rotura del enlace C17, 20. La inhibición del CYP17 produce también un aumento de la producción de mineralocorticoides por las glándulas suprarrenales.

El carcinoma prostático sensible al andrógeno responde al tratamiento que reduce los niveles de andrógeno. Los tratamientos de deprivación androgénica, tales como el tratamiento con análogos de LHRH o la orquiectomía, reducen la producción de andrógeno en las pruebas,

pero no afectan la producción de andrógeno en las glándulas suprarrenales o en el tumor. El tratamiento con abiraterona reduce la testosterona sérica hasta niveles indetectables (utilizando análisis comerciales) cuando se administra con análogos de la LHRH (u orquiectomía).

Efectos farmacodinámicos

Abiraterona disminuye la testosterona sérica y otros andrógenos hasta niveles inferiores a aquellos alcanzados por el uso de análogos de la LHRH solos o con orquiectomía. Estos resultados a partir de la inhibición selectiva de la enzima CYP17 requerida para la biosíntesis androgénica. La PSA sirve como biomarcador en pacientes con cáncer de próstata. En un estudio clínico Fase III realizado en pacientes en quienes había fallado la quimioterapia previa con taxanos, mostró que el 38% de los pacientes tratados con acetato de abiraterona versus el 10% de los pacientes que fueron tratados con placebo, presentaron por lo menos un 50% de reducción de los niveles de PSA respecto a los niveles basales.

Propiedades Farmacocinéticas

Después de la administración de acetato de abiraterona, se estudió la farmacocinética de abiraterona y del acetato de abiraterona en sujetos sanos, en pacientes con cáncer de próstata metastásico avanzado y sujetos sin cáncer con insuficiencia hepática o renal. El acetato de abiraterona *in vivo* se convierte rápidamente en abiraterona, un inhibidor de la biosíntesis de andrógenos.

Absorción
Después de la administración oral de acetato de abiraterona en ayunas, se tarda aproximadamente 2 horas en alcanzar la concentración plasmática máxima de abiraterona..

La administración del acetato de abiraterona con alimentos, comparado con la administración en ayunas, aumenta hasta en 10 veces (ABC) y hasta en 17 veces (C_{max}) la exposición sistémica media de abiraterona, dependiendo del contenido graso de la comida. Dado la variación normal en el contenido y composición de las comidas, la administración de abiraterona con las comidas tiene el potencial de resultar en exposiciones altamente variables. Por lo tanto, abiraterona no se deberá administrar junto con las comidas. Deberán transcurrir por lo menos dos horas después de haber comido y no deberá tomarse alimento por lo menos una hora después de haber tomado abiraterona. Las tabletas deberán tragarse enteras con agua.

Distribución
La unión a las proteínas plasmáticas de ^{14}C-abiraterona en el plasma humano es del 99.8%. El aparente volumen de distribución es de aproximadamente 5,630 l, sugiriendo esto que abiraterona se distribuye ampliamente a tejidos periféricos.

Biotransformación
Después de la administración oral del acetato de ^{14}C-abiraterona como cápsulas, el acetato

de abiraterona se hidroliza a abiraterona, que luego se somete a metabolismo incluyendo sulfación, hidroxilación y oxidación principalmente en el hígado. La mayoría de la radioactividad circulante (aproximadamente el 92%), se encuentra en forma de metabolitos de abiraterona. De los 15 metabolitos detectables, cada uno de los dos principales metabolitos, el sulfato de abiraterona y el sulfato de N-óxido abiraterona, representa aproximadamente un 43% del total de la radioactividad.

Eliminación

La semivida media de abiraterona en el plasma es de aproximadamente 15 horas con base en la información tomada de sujetos sanos. Después de la administración oral de 1000 mg de acetato de ^{14}C-abiraterona, aproximadamente el 88% de la dosis radioactiva se recupera en las heces y aproximadamente el 5% en la orina. Los mayores compuestos se presentan en las heces como acetato de abiraterona y abiraterona inalterados (aproximadamente 55% y 22% de la dosis administrada, respectivamente).

Insuficiencia hepática

La farmacocinética del acetato de abiraterona se examinó en sujetos con insuficiencia hepática preexistente leve o moderado (Child-Pugh Clase A y B, respectivamente) y en sujetos sanos de control. La exposición sistémica a abiraterona después de una dosis oral única de 1000 mg, se incrementó en aproximadamente el 11% y el 260% en sujetos con insuficiencia hepática pre-existente leve y moderada, respectivamente. La semivida media de abiraterona se prolongó a aproximadamente 18 horas en sujetos con insuficiencia hepática leve y a aproximadamente 19 horas en sujetos con insuficiencia hepática moderada.

En otro ensayo, se examinó la farmacocinética de abiraterona en sujetos con insuficiencia hepática preexistente grave (n = 8) [Child-Pugh Clase C] y en 8 sujetos sanos de control con función hepática normal. El ABC de abiraterona se incrementó en aproximadamente 600% y la fracción libre de medicamento aumentó en un 80% en sujetos con insuficiencia hepática severo, comparado con los sujetos con una función hepática normal.

No fue necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática preexistente leve.

El uso del acetato de abiraterona deberá evaluarse con precaución en pacientes con insuficiencia hepática moderada en quienes el beneficio claramente deberá superar el posible riesgo. El acetato de abiraterona no deberá utilizarse en pacientes con insuficiencia hepática grave.

Para pacientes que desarrollan hepatotoxicidad durante el tratamiento, se requerirá suspender el tratamiento y ajustar la dosis.

Insuficiencia renal

La farmacocinética del acetato de abiraterona se comparó en pacientes con enfermedad renal crónica terminal en un esquema de hemodiálisis estable versus sujetos pareados de control con una función renal normal. La exposición sistémica a abiraterona después de una dosis

oral única de 1000 mg, no se incrementó en sujetos en diálisis con enfermedad renal en estadio final. La administración en pacientes con insuficiencia renal, incluyendo insuficiencia renal grave, no requirió reducción de la dosis. Sin embargo, no se cuenta con experiencia clínica en pacientes con cáncer de próstata e insuficiencia renal grave. Se recomienda precaución en estos pacientes.

INFORMACION FARMACEUTICA

Vida útil:
36 meses

Almacenamiento:
Almacenar por debajo de 30°C

Presentación:
Frasco de polietileno de alta densidad (HDPE)

Versión 03 - Noviembre 2018